TUR Prostaat

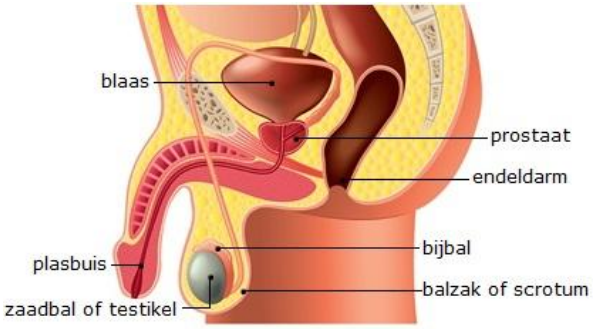
U wordt binnenkort opgenomen op de hospitalisatieafdeling Urologie voor een transurethrale resectie (TUR) van de prostaat.

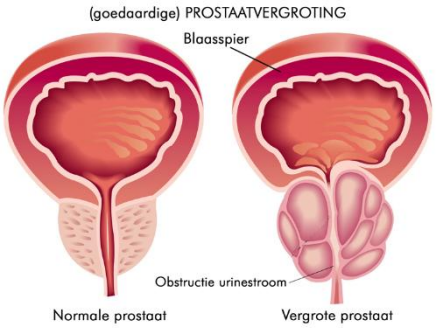
Deze brochure wil u informeren over de geplande ingreep en wegwijs maken in het verloop van uw hospitalisatie. Hebt u nog bijkomende vragen, dan kan u hiervoor uiteraard terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Wij wensen u alvast een spoedig herstel.

1. De prostaat

De prostaat is een klier die bestaat uit klierweefsel en omgeven wordt door een kapsel. Het klierweefsel produceert prostaatvocht dat wordt opgeslagen in de prostaat. De prostaat maakt deel uit van het mannelijk voortplantingssysteem.





De vorm en de grootte van een normale prostaat is vergelijkbaar met een kastanje. De prostaat zit in de onderbuik van de man, om de plasbuis heen, daar waar de plasbuis uit de blaas komt en overgaat in de penis.

Vanaf de leeftijd van 45-50 jaar kan er geleidelijk een goedaardige vergroting van de prostaat ontstaan. Doordat de prostaat rond de plasbuis ligt, kan de vergrote prostaat de plasbuis dichtdrukken. Hierdoor kunnen er plasklachten ontstaan.

Wanneer medicatie onvoldoende helpt of de klachten ernstig zijn, kan een TUR van de prostaat een doeltreffende oplossing bieden.

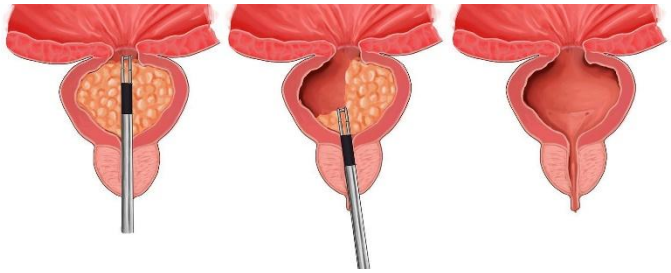
Video over BPH: https://youtu.be/ExLrO84Ojtw

2. TUR Prostaat

De ingreep die u zal ondergaan is een transurethrale resectie (TUR) van de prostaat. Deze ingreep wordt door de zorgverleners afgekort als TUR prostaat.

Een TUR prostaat gebeurt onder algemene verdoving (algemene narcose) of locoregionale verdoving (ruggenprik).

Tijdens de operatie brengt de uroloog een instrument in via uw plasbuis tot aan de prostaat. Via deze toegang kan de uroloog aan de hand van een elektrische lus uw prostaat uitschrapen. Het uitschrapen van de prostaat is vergelijkbaar met het uithollen van een sinaasappel, waarbij na het uithollen van de vrucht enkel nog de schil overblijft.



Afbeelding links toont het vooraanzicht van de prostaat bestaande uit prostaatkapsel met binnenin het klierweefsel. Via de plasbuis wordt een instrument ingebracht tot aan de prostaat.

Afbeelding midden toont het uithollen van de prostaat, waarbij het kapsel van de prostaat intact blijft.

Afbeelding rechts toont de prostaat na de ingreep.

Een goedaardige prostaatvergroting is geen prostaatkanker. Toch zal uw uroloog het verwijderde weefsel laten onderzoeken in een labo (anatomo-pathologisch onderzoek). Onderzoek van het weefsel is belangrijk om kwaadaardige letsels in de prostaat zeker uit te sluiten.

3. Complicaties

Elke ingreep houdt bepaalde risico's in. Zo ook deze minimaal invasieve operatie. Lichamelijke klachten zoals blaaskrampen, bloed in de urine, continue plasdrang, kleine plasvolumes en ongewild urineverlies zijn realistisch de eerste weken na deze ingreep.

Hieronder worden de mogelijke complicaties opgelijst:

Vaak voorkomende complicaties (meer dan 1 op 10)

- Retrograde ejaculatie (= droge zaadlozing): sperma loopt in de blaas bij een orgasme. Dit beïnvloedt de vruchtbaarheid, maar niet het orgasme.
- Irritatieve plasklachten in de eerste 4-6 weken (branderig gevoel, vaker moeten plassen, ongewild urineverlies)
- Bloedverlies in de urine (kan tot 6 weken na de ingreep)

Soms voorkomende complicaties (1 op 100 tot 1 op 10)

- Tijdelijk urineverlies (vooral bij hoesten/lachen)
- Urineweginfectie
- Toevallige vondst van prostaatkanker in het verwijderde weefsel

Zelden voorkomende complicaties (minder dan 1 op 100)

- Nabloeding die extra zorg vraagt: heropname voor het verwijderen van grote klonters
- Licht verminderde erectie
- Heringreep ikv residueel prostaatweefsel
- Blaashalsvernauwing of plasbuisvernauwing (urethrastrictuur)
- Langdurige incontinentie

4. Voorbereiding

Preoperatieve consultatie (POC)

Sommige patiënten worden best voorgaand aan de ingreep gezien door de anesthesist (indien je > 70j bent, een belangrijke medische voorgeschiedenis hebt, BMI > 35 hebt, of indien je 5 of meer geneesmiddelen neemt). Zij bekijken samen met u welke preoperatieve onderzoeken noodzakelijk zijn: bvb ECG of bloedafname. Of u bij de anesthesist dient langs te gaan, wordt besproken op de consultatie met uw behandelend Uroloog.

Urinestaal

Minstens 2-3 weken voor de ingreep dient een urinestaal via uw huisarts/ziekenhuis te worden binnengebracht om infectie na te gaan. In geval van infectie zullen wij u contacteren om antibiotica op te starten.

Medicatie

Bloedverdunners dienen meestal tijdelijk gestaakt te worden. Bespreek dit met uw behandelend Uroloog.

Antibiotica wordt voorafgaand aan de ingreep opgestart op advies van uw behandelend Uroloog in functie van een afwijkend urinestaal. Dit wordt telefonisch met u besproken, zorg dat wij steeds een geldig telefoonnummer van u in ons dossier hebben staan door dit via ons secretariaat door te geven.

Vergeet zeker niet uw thuismedicatie mee te brengen bij de opname. Bij voorkeur in de originele verpakking.

Uur van ingreep

Twee werkdagen voor de geplande operatiedatum wordt u telefonisch gecontacteerd om door te geven om welk uur u verwacht wordt in het ziekenhuis. Dit wordt afgestemd op het richt uur van de operatie maar is geen bevestiging van een bepaald uur, pin u dus niet per se vast op dit moment.

5. Opname op de hospitalisatieafdeling

Voor deze ingreep wordt u opgenomen op de hospitalisatieafdeling Urologie omdat u één nacht in het ziekenhuis moet blijven. U brengt dus nachtkledij, toilet- en wasgerief mee. Een paar pantoffels en eventueel een kamerjas zijn handig. Als u anti-emboliekousen (= TED-kousen) hebt van een eerdere operatie, breng die dan ook mee.

De verpleegkundige of secretaresse van de hospitalisatieafdeling zal u verwelkomen en u naar uw kamer begeleiden. De verpleegkundige stelt u nog enkele vragen om de zorg op u af te stemmen. Het uur waarop de ingreep vermoedelijk zal doorgaan, wordt u meegedeeld.

Omwille van de verdoving die u zal krijgen, mag u vanaf middernacht voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.

Als voorbereiding op de ingreep vragen wij u de intieme hygiëne te voorzien.

6. Moment van de ingreep

Op het ogenblik dat uw arts u naar de operatiezaal vraagt, zal de verpleegkundige u een operatiehemdje geven om aan te trekken. U trekt dan alle andere kledij uit, net zoals juwelen, kunstgebit, hoorapparaat of bril. De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de bedhold (wachtzaal voor patiënten die geopereerd zullen worden).

Voordat u in slaap wordt gebracht, zal de Anesthesist u nog enkele vragen stellen. Het is mogelijk dat u uw Uroloog niet meer zal zien vlak voor u in slaap gaat, omdat hij pas binnenkomt als u al slaapt.

De ingreep duurt ongeveer 1 uur.

7. Na de ingreep

Opname post-anesthesie zorgafdeling (PAZA)

Na de ingreep gaat u naar de PAZA of ontwaakzaal. Hier wordt u tijdens het ontwaken uit de verdoving strikt opgevolgd door de verpleegkundigen en de Anesthesist. U zal verbonden zijn met een monitor waarop uw bloeddruk, pols en ademhaling gevolgd worden. De verpleegkundigen geven u ook de voorgeschreven pijnstilling.

Na de ingreep hebt u ook een blaassonde doorheen uw plasbuis tot in de blaas. Dit is een soepel hol buisje, waarlangs de urine afloopt in een urinezak. Het hebben van een sonde is niet pijnlijk maar kan als onaangenaam ervaren worden. De sonde is eveneens verbonden met een grote spoelzak, waardoor het mogelijk is uw blaas continu te spoelen. De arts kiest voor deze continue spoeling omdat hij verwacht dat de prostaat mogelijk wat zal nabloeden. Opdat de sonde niet zou verstoppen wordt uw blaas dus

preventief schoongespoeld. De verpleegkundige zal uw urine nauwkeurig opvolgen en de snelheid van deze spoeling aanpassen naargelang de kleur van de urine.

Het is mogelijk dat de sonde toch verstopt ondanks de continue spoeling. Het is daarom belangrijk om de verpleegkundige te waarschuwen wanneer u een druk in de onderbuik of een toenemend plasgevoel ervaart. In bepaalde situaties moet het systeem ontkoppeld worden om bloed en klonters te verwijderen door middel van manuele spoeling.

Wanneer de Anesthesist beslist dat het veilig is om u terug naar de hospitalisatieafdeling te brengen, zullen de verpleegkundigen u komen halen en terugbrengen. Het is best mogelijk dat u zich achteraf niet alles meer herinnert van het verblijf op de PAZA.

Terug op de kamer

Wanneer u terug op uw kamer bent, zal de verpleegkundige u helpen uw nachtkledij aan te trekken. U mag nog niet uit bed en de eerste uren mag u ook nog niets eten of drinken. De verpleegkundige zal u laten weten wanneer u water mag beginnen drinken. ’s Avonds kunt u een licht avondmaal krijgen.

De continue blaasspoeling wordt verdergezet op de hospitalisatieafdeling tot de urine helder is. De verpleegkundige volgt de spoelvloeistof nauwkeurig op. Ook hier is het belangrijk dat u de verpleegkundige waarschuwt wanneer u een drukkend gevoel in de onderbuik of een toenemende plasdrank ervaart. Van zodra de urine helder is, wordt de spoeling gestopt. De ochtend na de ingreep zal de arts beslissen of de sonde verwijderd mag worden. Het verwijderen van de sonde kan onaangenaam aanvoelen maar is doorgaans niet pijnlijk.

Na het verwijderen van de sonde zal de verpleegkundige uw plas opvolgen. Het is best mogelijk dat het plassen na de ingreep branderig aanvoelt. Dit is normaal en kan tot 24u na het verwijderen van de sonde voorkomen. Na elke plas zal de verpleegkundige met een speciaal echotoestel (“bladderscan”) controleren of u voldoende leegplast.

8. Ontslag

De arts beslist wanneer u naar huis kan gaan. Voordat u naar huis gaat, krijgt u van de secretaresse of verpleegkundige een controleafspraak om terug te keren naar uw Uroloog. Tijdens deze afspraak zal de Uroloog u het resultaat van het weefselonderzoek toelichten.

9. Nazorg en verwachtingen thuis

Drink voldoende water: liefst 1.5l water mooi gespreid over de dag.

Vermijd persen bij stoelgang maken, zo nodig dient een laxativum gestart te worden. Eveneens helpen vezelrijke voeding en groene kiwi’s (tot 2 per dag) een vlotte stoelgang te bekomen

Relatieve rust wordt aangeraden gedurende 4 weken na de ingreep, dit betekent dat korte rustige wandelingen wel kunnen, maar grote fysieke inspanningen vermeden dienen te worden (bvb fietsen, zware lasten heffen, intensief sporten). Seksuele activiteit dient ook vermeden te worden de eerste 4 weken na de ingreep.

Bloedverdunners zullen na de ingreep gradueel herstart worden. Een concreet schema met de nodige voorschriften wordt voorzien bij ontslag, dit gaat frequent gepaard met Clexane® spuitjes ter overbrugging. De toediening van de spuitjes kan door een thuisverpleegkundige, waarvoor bij ontslag een thuiszorgattest wordt voorzien.

We raden gedurende 2 weken af om een warm bad te nemen of van een sauna gebruik te maken. Dit om het risico op nabloeding te vermijden. Douchen vormt geen probleem.

Alcoholgebruik dient tot 2 weken na de ingreep beperkt te worden, gezien het verhoogde risico op nabloeden door alcoholinname.

TED-kousen dienen thuis best nog 2 weken ’s nachts gedragen te worden gezien u dan minst in beweging bent.

In sommige situaties (bvb bij onmogelijkheid tot spontaan plassen na verwijderen van de sonde (= urinaire retentie)) dient de blaassonde in de blaas te blijven bij ontslag. De sonde wordt in dit geval doorgaans voor 7-10 dagen behouden en verwijderd via een dagopname op onze dienst.

Na de ingreep en het verwijderen van de sonde kan het zijn dat
- Er nog enkele dagen bloed in de urine te zien is
- Het plassen dringender verloopt met soms ongewild urineverlies
- Er een gevoel van blaasprikkeling of blaaskrampen is
- De plasvolumes eerder kleiner zijn
- Er een continue plasdrang is

Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en kunnen medicamenteus worden opgevangen door middel van anticholinergica (bvb solifenacine of oxybutynine) of β-3-adrenoceptor-agonist (bvb vibegron of mirabegron).

Deze ingreep heeft geen nadelig effect op de seksuele activiteit. U moet er alleen rekening mee houden dat het sperma bij een zaadlozing niet meer via de plasbuis naar buiten komt, doch in de blaas terecht komt. Dit wordt veroorzaakt door een breder openstaan van de blaashals na deze ingreep. Het gevoel blijft onveranderd, men spreekt van een ‘droge’ zaadlozing.

10. Alarmtekens

Alertheid voor eventuele complicaties is belangrijk. In volgende situaties raden wij aan uw Uroloog te contacteren of zich te melden via Spoedgevallen:
- Koorts boven de 38.5°C of koude rillingen
- Ernstige onderbuikspijn die met klassieke pijnstilling of de voorgeschreven medicatie niet onder controle geraakt
- Uitgesproken bloed in de urine met bloedklonters
- Onmogelijkheid te urineren of erg pijnlijke gevoel bij het plassen.

⇨ Indien u twijfelt over uw symptomen kan u steeds contact opnemen met de dienst Urologie.

11. Checklist: wat breng ik mee bij een opname?

- Thuismedicatie, bij voorkeur in de originele verpakking. Inclusief eventuele antibiotica of bloedverdunners.
- TED-kousen zo u dit heeft
- Nachtkledij
- Toiletgerief
- GSM en oplader
- Eventuele vragenlijsten of papieren die u nog waren gevraagd in te vullen
- Verzekeringspapieren die dienen getekend te worden door de arts

12. Vragen? Noteer ze hieronder.

13. Contact

Hospitalisatieafdeling Urologie
Tel. 09 332 27 61

Polikliniek Urologie
Tel. 09 332 22 76